

老年巨幼细胞贫血患者临床特点及治疗措施的研究

迟文静

河北省南皮县人民医院消化血液科 河北 沧州 061500

摘要 目的：对老年巨幼细胞性贫血患者的临床特点进行分析，同时对该疾病的治疗措施进行探讨。方法：选取2020年1月—2022年12月本院收治的老年巨幼细胞性贫血患者16例，回顾性分析患者的发病原因、临床特点，分析患者治疗前及接受综合治疗后，血常规各项指标变化情况。结果：消化系统疾病是导致老年人出现巨幼细胞性贫血的最主要原因，其次为不良饮食习惯，第三则是心脑血管疾病；中度贫血患者占比最高，为50.00%，轻度及重度占比分别为18.75%、31.25%；治疗后，患者的血红蛋白、白细胞计数、血小板计数、网织红细胞计数、红细胞平均体积水平均高于治疗前（ $P<0.05$ ）。结论：导致老年人出现巨幼细胞性贫血的原因主要有消化系统疾病、不良饮食习惯等，为有效治疗该疾病，应对患者的原发疾病进行积极的治疗，纠正患者的不良饮食习惯，加强营养摄入，指导患者摄入维生素B12、叶酸含量丰富的食物。

关键词 巨幼细胞性贫血；老年；临床特征；治疗措施

引言

巨幼细胞性贫血是一种由于维生素B12和（或）叶酸缺乏导致细胞DNA合成障碍所致的贫血症状，在这种病症中，骨髓无法正常生成足够的健康红细胞，从而导致贫血，表现为乏力、疲劳、气短、食欲不振、肢体麻木等症状^[1]。维生素B12和叶酸在红细胞生成过程中起着关键作用，它们的缺乏会影响红细胞的正常发育，导致巨幼红细胞生成，进而引发贫血^[2]。在社会经济水平以及生活水平不断上升的今天，临床上患者的贫血症状已经得到了较好的治疗，不过还是不能够从根本上对贫血进行改善，贫血出现的原因较为多样，而年龄就是其中的一个重要影响因素^[3]。本研究针对16例老年巨幼细胞性贫血患者的临床特点进行了分析，同时对其治疗措施进行了探讨，现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月—2022年12月本院收治的老年巨幼细胞性贫血患者16例，其中男11例，女5例；年龄55~80岁，平均年龄（ 71.34 ± 4.56 ）岁；患者症状到就诊时间为1个月~2年，平均时间为（ 1.17 ± 0.43 ）年。所有患者对本研究内容知情同意并签署协议书，研究通过伦理委员会审批。

纳入标准：①符合老年巨幼细胞性贫血诊断标准^[4]；

a.患者在既往存在较长时间的营养缺乏情况，同时在临床上的表现为贫血症状；b.患者血常规检验结果显示，外周红细胞（RBC）、血红蛋白（Hb）低于正常值，或存在血小板（PLT）、白细胞计数（WBC）水平降低的情况，同时其红细胞平均体积（MCV）高于正常值；c.患者骨髓涂片检查可见典型的骨髓增生，或明显活跃，可见“老浆幼核”现象，或者粒细胞、巨核细胞见巨幼样变，但未发生原始细胞含量明显增加的情况；d.给予患者维生素B12或叶酸能够取得较为有效的治疗效果；e.排除由慢性肝脏疾病、药物作用或血液疾病导致的骨髓红系巨幼细胞改变。②年龄55~80岁。

排除标准：①患者在精神系统方面存在异常，或患者认知与常人不同；②除巨幼细胞性贫血外，合并其它全身性免疫系统疾病。

1.2 方法

①积极治疗患者原发疾病；②若患者存在叶酸缺乏，则给予患者叶酸片口服进行治疗，10mg/次，3次/d，连续服用1~2个月，在患者血红蛋白恢复正常范围后结束治疗；③若患者存在维生素B12缺乏，则采用维生素B12针为患者实施治疗，500 μ g/次，肌肉注射，2次/周，每隔3周适量减少剂量，在患者的血红蛋白恢复至正常范围后结束治疗，若是患者在治疗期间出现神经系统症状，则连续治疗1年，若患者为恶性贫血，则需进行终身治疗；④若患者的一般情况较好，则不为患者输注红细胞悬液；

⑤若患者合并缺铁性贫血，则要为患者补充铁剂^[5]；⑥指导患者纠正不良的饮食习惯，保持合理的饮食方案，适当增加维生素B12以及叶酸的食物含量；⑦结合患者的贫血情况为患者实施药物治疗，例如口服利血生20mg/次，3次/d，口服益血生胶囊4粒/次，3次/d。

1.3 观察指标

①分析老年巨幼细胞性贫血患者的病因：主要包括4个方面，分别为消化系统疾病、不良饮食习惯、心脑血管疾病、其他。②分析老年巨幼细胞性贫血患者的临床特点：包括贫血症状（乏力、头晕、心悸）、消化道症状（纳差、偏食、恶心呕吐）、其他症状（消瘦、皮肤出血、手足麻木）及贫血程度（轻度、中度、重度）。③对比治疗前后老年巨幼细胞性贫血患者的血常规指标：血常规检查项目主要包含Hb、WBC、PLT、网织红细胞计数（RC）、MCV。

1.4 统计学方法

数据使用SPSS 22.0软件处理，计数资料以[n（%）]表示，采取 χ^2 检验。计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，采取t检验。 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 老年巨幼细胞性贫血的病因分析

消化系统疾病是导致老年巨幼细胞性贫血的最主要原因，其次为不良饮食习惯，第三则是心脑血管疾病。见表1。

2.2 老年巨幼细胞性贫血的临床特点分析

患者的贫血症状包括：乏力8例（50.00%），头晕4例（25.00%），心悸2例（12.50%）；患者的消化道症状包括：纳差9例（56.25%），偏食4例（25.00%），恶心呕吐2例

（12.50%）；其他症状包括：消瘦1例（6.25%），皮肤出血1例（6.25%），手足麻木1例（6.25%）；中度贫血占比最高，为50.00%，轻度及重度占比分别为18.75%、31.25%。见表2。

表1 老年巨幼细胞性贫血的病因分析（n，%）

项目	n	构成比
消化系统疾病	7	43.75
不良饮食习惯	4	25.00
心脑血管疾病	3	18.75
其他	2	12.50
总例数	16	100.00

表2 老年巨幼细胞性贫血的临床特点分析（n，%）

	临床特点	n	构成比
贫血程度	轻度（Hb $\geq$ 90g/L）	3	18.75
	中度（Hb在60~90g/L之间）	8	50.00
	重度（Hb在30~60g/L之间）	5	31.25
	极重度（Hb $<$ 30g/L）	0	0
贫血症状	乏力	8	50.00
	头晕	4	25.00
	心悸	2	12.50
消化道症状	纳差	9	56.25
	偏食	4	25.00
	恶心呕吐	2	12.50
其他症状	消瘦	1	6.25
	皮肤出血	1	6.25
	手足麻木	1	6.25

2.3 老年巨幼细胞性贫血治疗前后血常规对比

治疗后，患者的Hb、WBC、PLT、RC、MCV水平平均高于治疗前（ $P < 0.05$ ），见表3。

表3 老年巨幼细胞性贫血治疗前后血常规比较（ $\bar{x} \pm s$ ）

时间	n	Hb（g/L）	WBC（ $10^9/L$ ）	PLT（ $10^9/L$ ）	RC（%）	MCV（fl）
治疗前	16	63.55 $\pm$ 8.54	3.67 $\pm$ 1.08	96.33 $\pm$ 15.28	0.35 $\pm$ 1.09	62.29 $\pm$ 8.48
治疗后	16	82.32 $\pm$ 10.68	5.94 $\pm$ 1.36	122.16 $\pm$ 21.31	1.25 $\pm$ 0.27	83.83 $\pm$ 10.05
t值		5.490	5.228	3.940	3.206	6.552
P值		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

伴随着老龄化社会的到来，老年疾病的发生率不断增加，因此社会对老年疾病的关注度也在不断提升。在老年人群中，贫血症状较为普遍，且近年来贫血的发生率呈现出了上升的趋势。导致巨幼细胞性贫血最主要的原因是维生素B12以及

叶酸的缺乏，而在老年群体中，该疾病通常为其他疾病的继发性疾病，并且临床症状并不典型^[6]。在老龄人口不断增加的今天，老年巨幼细胞性贫血的发生率也在不断增加，因此临床上对于该疾病需要提高重视，加强管理。人体中的维生素B12补（下转第237页）

[2] 故丽结克热·阿布都力克木,阿尔孜古丽·阿布迪海力,买买提艾力·阿木提.孜马地疗法治疗卵巢囊肿疗效观察[J].中国民族医药杂志,2019,25(9):2-4.

[3] 阿尔孜古丽·阿布迪海力,买买提艾力·阿木提,故丽结克热·阿布都克力木,等.维吾尔医综合疗法治疗卵巢囊肿76例[J].中国民族医药杂志,2019,25(2):14-15.

[4] 阿地拉·米拉吾提,艾合太尔克孜·木沙,买买提艾力·阿木提.维吾尔

医治疗用于卵巢囊肿患者中的效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(17):152,155.

[5] 阿尔孜古丽·阿布迪海力,买买提艾力·阿木提,故丽结克热·阿布都克力木,等.浅谈卵巢囊肿维吾尔医发病机制[J].中国民族医药杂志,2019,25(1):59-60.

[6] 古力娜尔·阿布都克由木.维吾尔医籽麻德疗法治疗卵巢囊肿60例临床观察[J].现代医学与健康研究电子杂志,2018,2(6):162.

(上接第108页)

充主要依赖外源性的食物摄入,例如禽蛋、动物肝肾、鱼、肉等,而叶酸的补充主要依靠新鲜蔬菜、动物肝肾等。长期慢性的胃部疾病或曾接受过胃切除手术,都有可能引起叶酸以及维生素B12的吸收出现障碍,进而导致贫血的发生^[7]。

本次研究结果发现,消化系统疾病是导致老年巨幼细胞性贫血发生的最主要原因,其次分别为不良饮食习惯以及心脑血管疾病,可见巨幼细胞性贫血的发生以及预后和患者的原发疾病存在较大的联系,因此需要及时给予患者积极的原发疾病治疗干预。一般在经过5~7d的治疗后,患者的RC开始逐渐升高,其后Hb以及红细胞比容也会出现逐渐上升;经过7~10d的治疗后,患者的PLT、粒细胞相关指标以及其他实验室异常指标会恢复至正常范围;经过1~2个月的治疗后,患者的Hb可以恢复至正常范围^[8]。

本次研究结果发现,中度贫血占比最高,为50.00%,轻度及重度占比分别为18.75%、31.25%;经过治疗后,患者的Hb、WBC、PLT、RC、MCV水平平均高于治疗前,可见为患者接受叶酸及维生素B12治疗可以有效改善患者的贫血情况。分析其原因在于,积极治疗干预患者的原发疾病,能够使患者的病情得到有效的控制,而给予患者饮食指导,纠正患者的不良饮食习惯能够使患者的机体得到充足的营养供应;在细胞DNA合成过程中,维生素B12以及叶酸能够起到重要的辅酶活性作用,若是这两种物质缺乏,就会导致DNA的合成受到影响,速度减慢,与此同时,胞质中的RNA会继续成熟,因此DNA以及RNA比例失衡,导致细胞核浆的发育失去平衡,最终导致细胞体积大但是核发育比较不成熟,这也就是“巨幼变”^[9]。而在巨核细胞以及粒细胞中也能够出现这种巨幼变,在细胞出现巨幼变后,其在骨髓内还没有成熟就受到了破坏,使得造血效果受到了影响,最终导致了巨幼细胞性贫血的发生。而维生素B12和叶酸可以对正常原血细胞的增殖与成熟起到促进作用,促进红

细胞的产生,因此患者的巨幼红细胞性贫血症状能够得到有效的改善^[10]。

综上所述,导致老年人出现巨幼细胞性贫血的原因主要有消化系统疾病、不良饮食习惯等,为有效治疗该疾病,应对患者的原发疾病进行积极的治疗,纠正患者的不良饮食习惯,加强营养摄入,指导患者摄入维生素B12、叶酸含量丰富的食物。

参考文献

[1] 秦红群,马顺高,马稚强,等.226例巨幼细胞性贫血临床病例分析[J].医学理论与实践,2017,30(7):958-960.

[2] 刘玉香.老年巨幼细胞性贫血临床治疗分析[J].心理医生,2018,24(27):98-99.

[3] 闫丽娜.老年全血细胞减少症的临床分析[J].中国保健营养,2017,27(25):271.

[4] 张之南,沈悌.血液病诊断及疗效标准[M].3版.北京:科学出版社,2007:12-14.

[5] 周栋,慕俐君,张旗,等.133例老年大细胞性贫血的病因分析及实验室指标的诊断价值[J].中国实验血液学杂志,2019,27(1):202-207.

[6] 陆琴.以消化道症状为主要表现的巨幼细胞性贫血33例分析[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(8):40.

[7] 何苗,白海,韩燕霞,等.西北甘肃高海拔地区62例巨幼细胞性贫血实验室结果及病因分析[J].检验医学与临床,2018,15(20):3014-3016.

[8] 梁筱灵,张景荣,王彩丽.14例儿童巨幼细胞性贫血的病因分析[J].微量元素与健康研究,2017,34(3):29-30.

[9] 阿爽,江晓蕾.不同类型贫血患者血液检验结果对比研究[J].临床检验杂志(电子版),2018,7(2):213-214.

[10] 杨丽丽.老年性贫血24例住院患者临床分析[J].中国继续医学教育,2018,10(21):79-81.